

Plano do Volume I e II

1. Identificação e referenciação
 2. História familiar
 3. Gravidez, parto e período neonatal
 4. História do desenvolvimento
 5. História médica
 6. Funcionamento atual
 7. História escolar
 8. Síntese clínica inicial
-

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Volume I

INFORMAÇÃO DO PACIENTE

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

1. Anamnese Clínica Integrada

Módulo 1 – Identificação e Referenciação

1. Dados da Criança

Campo	Informação
Nome completo	
Data de Nascimento	
Idade	
Sexo	
Ano de escolaridade	
Escola	
Turma	
Professor(a)/DT/Educador	
Morada	
Contacto	
NIF	
N.º SNS	
Seguro de Saúde nº	

2. Pais/Cuidadores

• Mãe:

Nome: _____

Idade: _____

Escolaridade: _____

Profissão: _____

Contacto: _____

• Pai:

966419142
danielosantos.consultas@gmail.com
Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Nome: _____

Idade _____

Escolaridade _____

Profissão _____

Contacto _____

• Outros cuidadores, quem? _____

Nome: _____

Idade _____

Escolaridade _____

Profissão _____

Contacto _____

3. Motivo da Referenciação

Quem encaminhou?

☐ Pais ☐ Escola ☐ Pediatra ☐ Neuropediatra ☐ Psicólogo ☐ Médico de Família ☐ Outro

Motivo principal:

3.1 – Consulta de Psicologia

Alguma vez esteve em consulta de Psicologia?

Sim__ Não__

Se sim qual o motivo da consulta?

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

4. Objetivos da Referenciação/Avaliação:

- ☐ Desenvolvimento
- ☐ Aprendizagem
- ☐ PHDA
- ☐ PEA
- ☐ Linguagem
- ☐ Emoções
- ☐ Comportamento
- ☐ Outro: _____
- ☐ sem motivo aparentemente diagnosticado

Principais preocupações até ao momento:

Já fez consultas de outra especialidade?

Sim___ Não___

Se sim qual a especialidade? _____

Por que motive realizou essa consulta? _____

Qual o resultado da consulta? _____

Síntese Clínica Inicial (a preencher apenas pelo Psicólogo)

Principais preocupações:

Fatores predisponentes identificados:

Fatores protetores:

Hipóteses clínicas iniciais:

2. História Familiar e Contexto Familiar

Objetivo Clínico

Este módulo destina-se à recolha sistemática de informação sobre o contexto familiar, os fatores predisponentes, fatores protetores e acontecimentos relevantes para a conceptualização clínica da criança/adolescente.

1. Fontes de Informação

- ☐ Mãe ☐ Pai ☐ Ambos ☐ Outro cuidador ☐ Criança/Adolescente
☐ Escola ☐ Relatórios anteriores ☐ Observação Clínica ☐ Outros

2. Composição do Agregado Familiar

Nome	Idade	Parentesco	Vive com a criança	Qualidade da relação

3. Alterações Familiares Significativas

- ☐ Separação parental
☐ Divórcio
☐ Novo companheiro
☐ Nascimento de irmão
☐ Falecimento
☐ Mudança de residência
☐ Institucionalização
☐ Outro: _____

4. Vinculação

Figura principal de vinculação:

- ☐ Mãe ☐ Pai ☐ Ambos ☐ Avós ☐ Outro

Reação à separação:

- ☐ Tranquilo ☐ Alguma ansiedade ☐ Chora ☐ Recusa separar-se ☐ Crise intensa

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

5. Relação Familiar

Relação com a mãe:

Relação com o pai:

Relação com irmãos:

6. Estilo Educativo

Característica	Nunca	Às vezes	Frequentemente
Regras consistentes	☐	☐	☐
Limites claros	☐	☐	☐
Reforço positivo	☐	☐	☐
Gritos	☐	☐	☐
Castigos	☐	☐	☐
Negociação	☐	☐	☐
Sobreproteção	☐	☐	☐

7. Antecedentes Familiares

Condição	Mãe	Pai	Família materna	Família paterna
PHDA	☐	☐	☐	☐
PEA	☐	☐	☐	☐
Dislexia	☐	☐	☐	☐
Perturbações da Linguagem	☐	☐	☐	☐
Ansiedade	☐	☐	☐	☐
Depressão	☐	☐	☐	☐
Epilepsia	☐	☐	☐	☐

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
 Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Outras	☐	☐	☐	☐
--------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

8. Acontecimentos de Vida Significativos

Descreva acontecimentos relevantes, idade de ocorrência e impacto percebido.

9. Integração Clínica (Preenchimento pelo Psicólogo)

Fatores Predisponentes:

Fatores Protetores:

Vulnerabilidades:

Recursos Familiares:

Hipóteses Clínicas Iniciais:

Questões a Explorar:

Notas Clínicas

- Valorizar a qualidade da vinculação e a consistência das práticas parentais.
- Identificar acontecimentos de vida potencialmente precipitantes.
- Registrar fatores protetores familiares relevantes para o plano de intervenção.
- Integrar esta informação na Formulação de Caso (5 P's).

3. Gestação, Parto e Período Neonatal

Objetivo Clínico

Recolher informação sobre fatores pré-natais, peri-natais e neonatais relevantes para a conceptualização clínica, identificando fatores predisponentes e fatores de risco do neurodesenvolvimento.

1. Planeamento da Gravidez

- ☐ Gravidez planeada ☐ Não planeada ☐ Fertilidade medicamente assistida
- ☐ Gravidez de risco
- ☐ Gravidez sem intercorrências até ao final da gestação
- Idade materna: _____ Idade paterna: _____
- Observações: _____

2. Gravidez

- ☐ Sem intercorrências ☐ Diabetes gestacional ☐ Hipertensão ☐ Pré-eclâmpsia
- ☐ Infeções ☐ Hemorragias ☐ Hospitalizações ☐ Consumo de álcool/tabaco/drogas
- ☐ enjoos e vómitos
- ☐ Medicação durante a gravidez: _____
- ☐ Stress significativo ☐ Ansiedade ☐ Depressão
- Durante a gravidez a criança era:
- ☐ agitada ☐ muito mexida ☐ demasiado calma e sem se mexer muito ☐ mais ativa à noite ☐ mais ativa durante o dia
- Observações: _____

3. Parto

- Semanas de gestação: _____
- ☐ Eutócico ☐ Cesariana ☐ Ventosa ☐ Fórceps
- Peso: _____ Comprimento: _____ APGAR 1': _____ 5': _____ 10': _____
- Complicações: _____

4. Período Neonatal

- ☐ Alta com a mãe ☐ Internamento em Neonatologia
- ☐ Icterícia ☐ Convulsões ☐ Dificuldades respiratórias ☐ Alimentação materna
- Observações: _____

5. Primeiros Meses de Vida

- Sono: _____
- ☐ regular ☐ com interrupções
- Horas de sono noturnas: _____
- ☐ dormiu no berço no quarto dos pais até ____ Meses
- ☐ quarto próprio aos ____ meses/anos
- Alimentação: _____
- ☐ alimentação exclusivamente materna ☐ alimentação com leite de fórmula ☐ ambas

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

- Temperamento: ☐ Calmo ☐ Irritável ☐ Muito ativo ☐ Difícil de consolar
- Vinculação precoce: _____
- ☐ com a Mãe exclusivamente ☐ com o pai exclusivamente ☐ com ambos ☐ outro cuidador/familiar - quem? _____
- Foram percebidas alterações auditivas? Sim ☐ Não ☐
- Convulsões febris? Sim ☐ Não ☐

Indicadores Clínicos de Alerta (A preencher pelo Psicólogo)

Indicador	Presente	Notas
Prematuridade (<37 semanas)	☐	
Baixo peso ao nascer	☐	
Hipóxia/sofrimento fetal	☐	
Internamento neonatal	☐	
Exposição pré-natal a substâncias	☐	
Complicações obstétricas	☐	

Integração Clínica (a preencher pelo psicólogo)

Fatores predisponentes identificados:

Fatores protetores:

Questões a explorar:

Hipóteses clínicas iniciais:

Notas para o Psicólogo

- Valorizar a interação entre fatores biológicos e ambientais.
- Integrar esta informação com a história do desenvolvimento e os resultados da avaliação.
- Assinalar acontecimentos que possam constituir fatores predisponentes na Formulação de Caso.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

4. História do Desenvolvimento

Objetivo Clínico

Avaliar os principais marcos do desenvolvimento, identificar fatores predisponentes do neurodesenvolvimento, áreas de competência e sinais de alerta relevantes para a formulação de caso.

1. Desenvolvimento Motor Grosso

Idade em que se sentou sem apoio: _____

Idade em que gatinhou: _____

Idade dos primeiros passos: _____

Subia escadas: _____

Observações: _____

2. Desenvolvimento Motor Fino

Preensão adequada (uso da pinça como caranguejo? – indicador e polegar): ☐ Sim ☐ Não

Manipulação de objetos: _____

Grafomotricidade: _____

3. Desenvolvimento da Linguagem

Primeiras palavras: _____

Primeiras frases: _____

Compreensão: ☐ Adequada ☐ Atrasada

Expressão: ☐ Adequada ☐ Atrasada

Pragmática: _____

Atraso no desenvolvimento da linguagem: Sim ☐ Não ☐

4. Comunicação Social

☐ Contacto ocular adequado

☐ Aponta para partilhar interesses

☐ Responde ao nome

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

☐ Inicia interação

☐ Mantém conversa

☐ usa o adulto como extensão dele próprio para atingir o que quer

5. Brincadeira

☐ Exploratória ☐ Funcional ☐ Simbólica ☐ Regras

Brincadeiras preferidas: _____

6. Desenvolvimento Emocional

Reconhece emoções: ☐ Sim ☐ Não

Expressa emoções: _____

Regulação emocional: _____

Consegue regular as suas emoções sem a presença do adulto? Sim ☐ Não ☐

7. Autonomia

Vestir-se: _____

Alimentação: _____

Higiene: _____

Controlo de esfíncteres: _____ Noturno ☐ Diurno ☐

8. Perfil Sensorial

☐ Hipersensibilidade auditiva

☐ Hipossensibilidade

☐ Seletividade alimentar

☐ Procura sensorial

Observações: _____

Indicadores Clínicos de Alerta (a preencher pelo psicólogo)

Indicador	Presente	Gravidade	Observações
Atraso motor	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Atraso da linguagem	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	
Ausência de jogo simbólico	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	
Défice de contacto ocular	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	
Rigidez comportamental	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	
Dificuldades de autorregulação	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	
Coordenação motora fraca	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	
Atraso adaptativo	☐	☐ Ligeiro ☐ Mod. ☐ Grave	

Integração Clínica

Áreas fortes:

Vulnerabilidades:

Fatores predisponentes:

Hipóteses clínicas:

Avaliações complementares sugeridas:

Notas para o Psicólogo

966419142
 danielasantos.consultas@gmail.com
 Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
 Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Relacionar os marcos do desenvolvimento com a história pré/peri-natal, funcionamento atual e resultados das provas psicológicas. Os indicadores de alerta devem orientar hipóteses diferenciais e a seleção de instrumentos de avaliação.

5. Funcionamento Atual

Objetivo Clínico

Caracterizar o funcionamento atual da criança/adolescente nos diferentes contextos, integrando indicadores cognitivos, emocionais, comportamentais, sociais e adaptativos.

Atenção e Funções Executivas

- Mantém a atenção nas tarefas ☐ Nunca ☐ Às vezes ☐ Frequentemente
- Segue instruções ☐ Sim ☐ Parcialmente ☐ Não
- Planeamento/organização: _____
- Flexibilidade cognitiva: _____
- Completa tarefas e conclui as mesmas: _____

Memória e Aprendizagem

- Memória imediata: _____
- Memória de trabalho: _____
- Leitura: _____
- Escrita: _____
- Matemática: _____

Linguagem

- Compreensão verbal: _____
- Expressão verbal: _____
- Pragmática: _____

Funcionamento Emocional

- Reconhecimento emocional: _____
- Regulação emocional: _____
- Ansiedade: ☐ Ausente ☐ Ligeira ☐ Moderada ☐ Grave
- Autoestima: _____
- Medos: _____
- Evitamentos: _____
- Recusas: _____

Comportamento

- Impulsividade: _____
- Agressividade: _____
- Oposição: _____

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

- Rigidez: _____

Competências Sociais

- Relação com pares: _____
- Relação com adultos: _____
- Empatia: _____
- Bullying (vítima/agressor/testemunha): _____
- Prefere estar com adultos: sim ☐ não ☐
- Tem amigos preferidos: sim ☐ não ☐

Autonomia

- Higiene pessoal: _____
- Gestão de rotinas: _____
- Trabalhos de casa: _____
- Precisa de ajuda para estas tarefas? Sim ☐ Não ☐

Sono e Alimentação

- Qualidade do sono: _____
- Hábitos alimentares: _____
- Nº horas de sono: _____
- Hora de deitar: _____
- Hora de acordar: _____
- Despertares noturnos? Sim ☐ não ☐

Integração com Instrumentos de Avaliação (a preencher pelo psicólogo)

Instrumentos a aplicar	Resultados relevantes	Integração clínica
WISC/WPPSI		
Griffiths		
BANC		
D2		
Figura Complexa de Rey		
Conners pais/professores		
ASEBA pais/professores		
YSR autopreenchimento		
BRIEF pais/autopreenchimento		
Outros		
Adexi		
Chexi		
SQP pais e professores		

Síntese Clínica do Funcionamento Atual

Áreas fortes:

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Principais dificuldades:

Impacto funcional:

Fatores de manutenção:

Objetivos prioritários:

Notas Clínicas

Relacionar o funcionamento atual com os fatores predisponentes, precipitantes, protetores e de manutenção. Integrar a informação proveniente da observação clínica, anamnese e provas psicológicas.

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

6. Percurso Escolar e Funcionamento Académico

Objetivo Clínico

Caracterizar o percurso escolar da criança/adolescente, identificando fatores de proteção, dificuldades académicas, adaptações, impacto funcional e necessidades educativas.

Creche

Idade de ingresso: _____

Adaptação: ☐ Fácil ☐ Moderada ☐ Difícil (especificar)

Relação com educadores: _____

Relação com pares: _____

Principais observações: _____

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Nº horas por semana na creche: _____

Pré-Escolar

Idade de ingresso: _____

Adaptação: ☐ Fácil ☐ Moderada ☐ Díficil (especifique)

Relação com educadores: _____

Relação com pares: _____

Principais observações: _____

Nº horas por semana na pré-escola: _____

1.º Ciclo (preencher caso se aplique)

Adaptação ao 1.º ciclo: _____

Dificuldades de leitura: _____

Dificuldades de escrita: _____

Dificuldades de matemática: _____

Comportamento em sala: _____

2.º/3.º Ciclo e Secundário (preencher caso se aplique)

Adaptação às mudanças de ciclo: _____

Organização do estudo: _____

Motivação escolar: _____

Relação com professores: _____

Relação com colegas: _____

Funcionamento Académico Atual (preencher caso se aplique)

Domínio	Sem dificuldade	Alguma dificuldade	Dificuldade significativa
Leitura	☐	☐	☐
Escrita	☐	☐	☐

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Ortografia	☐	☐	☐
Expressão escrita	☐	☐	☐
Matemática	☐	☐	☐
Atenção	☐	☐	☐
Organização	☐	☐	☐
Trabalho de casa	☐	☐	☐
Estudo autónomo	☐	☐	☐

Apoios Educativos

- ☐ Medidas Universais
- ☐ Medidas Seletivas
- ☐ Medidas Adicionais
- ☐ Terapia da Fala
- ☐ Psicologia
- ☐ Educação Especial
- ☐ Outro: _____

Participação Escolar

Assiduidade: _____

Pontualidade: _____

Participação em sala: _____

Autonomia nas tarefas: _____

Integração Clínica (a preencher pelo psicólogo)

Fatores protetores escolares:

Fatores de risco escolares:

Impacto funcional:

Necessidades educativas:

966419142
danielasantos.consultas@gmail.com
Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Recomendações iniciais:

Notas para o Psicólogo

Integrar a informação escolar com os resultados da avaliação psicológica, observação clínica e anamnese. Identificar fatores precipitantes e de manutenção associados ao contexto escolar e preparar recomendações pedagógicas.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Volume I

PSICÓLOGO

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Módulo 7 – Observação Clínica e Exame do Estado Mental

Objetivo Clínico

Registar sistematicamente as observações comportamentais realizadas durante toda a avaliação, integrando-as posteriormente na formulação de caso.

1. Impressão Geral

Indicador	Observação	Alerta	Integração Clínica (5 P's)
Aspeto geral		☐	
Cuidados de higiene		☐	
Postura		☐	
Contacto inicial		☐	
Cooperação		☐	
Motivação		☐	

2. Comunicação e Linguagem

Indicador	Observação	Alerta	Integração Clínica (5 P's)
Contacto ocular		☐	
Expressão facial		☐	
Compreensão verbal		☐	
Expressão verbal		☐	
Pragmática		☐	
Prosódia		☐	

3. Atenção e Atividade Motora

Indicador	Observação	Alerta	Integração Clínica (5 P's)
Atenção sustentada		☐	
Distratibilidade		☐	

Hiperatividade		☐	
Impulsividade		☐	
Planeamento motor		☐	

4. Afeto e Humor

Indicador	Observação	Alerta	Integração Clínica (5 P's)
Humor predominante		☐	
Labilidade emocional		☐	
Ansiedade observável		☐	
Tolerância à frustração		☐	

5. Interação Social

Indicador	Observação	Alerta	Integração Clínica (5 P's)
Iniciativa social		☐	
Reciprocidade		☐	
Relação com os pais		☐	
Relação com o avaliador		☐	

6. Brincadeira e Exploração

Indicador	Observação	Alerta	Integração Clínica (5 P's)
Jogo simbólico		☐	
Criatividade		☐	
Flexibilidade		☐	
Interesses restritos		☐	

Pérolas Clínicas

- Observar o comportamento espontâneo antes do início formal da avaliação.
- Comparar o relato dos cuidadores com a observação direta.
- Registar discrepâncias entre diferentes contextos.

Texto para Relatório

Observação clínica:

Síntese Clínica

Pontos fortes:

Vulnerabilidades:

Hipóteses diferenciais:

Provas complementares sugeridas:

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Volume I – Módulo 8

Síntese Clínica Inicial e Formulação de Caso

Objetivo Clínico

Integrar a informação recolhida na anamnese, observação clínica e avaliação psicológica, formular hipóteses clínicas fundamentadas e definir prioridades de intervenção.

1. Motivo Principal da Avaliação

2. Síntese da Informação Recolhida

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

3. Integração dos Instrumentos de Avaliação

Instrumento	Resultados Relevantes	Integração Clínica
Griffiths		
WPPSI/WISC		
BANC		
D2		
Figura Complexa de Rey		
ASEBA		
Conners		
BRIEF		
Outros		

4. Formulação Clínica (Modelo dos 5 P's)

Problema Principal

Fatores Predisponentes

Fatores Precipitantes

Fatores Perpetuantes

Fatores Protetores

5. Formulação Cognitivo-Comportamental

Situação desencadeante

↓

Pensamentos automáticos

↓

Emoções

↓

Respostas fisiológicas

↓

Comportamentos

↓

Consequências

↓

Manutenção do problema

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

6. Áreas Fortes

7. Vulnerabilidades

8. Hipóteses Clínicas

9. Impacto Funcional

10. Objetivos Prioritários da Intervenção

Curto Prazo

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Médio Prazo

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

Longo Prazo

- ☐ _____
- ☐ _____
- ☐ _____

11. Recomendações Iniciais

12. Impressão Clínica Global

Módulo 9 - Plano Integrado de Intervenção e Monitorização Clínica

Objetivo Clínico

Definir um plano de intervenção individualizado, baseado na formulação de caso, estabelecendo objetivos terapêuticos, estratégias, indicadores de progresso e critérios de reavaliação.

1. Diagnóstico Clínico / Hipóteses Diagnósticas

2. Prioridades de Intervenção

3. Objetivos SMART

4. Plano Terapêutico por Área

Área	Objetivo	Estratégias	Responsável	Prazo
Cognição				
Linguagem				
Motricidade				
Emoções				
Comportamento				
Competências Sociais				
Autonomia				
Aprendizagem				

5. Estratégias para a Família

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

6. Estratégias para a Escola

7. Articulação Multidisciplinar

8. Indicadores de Evolução

Indicador	Linha de Base	Meta	Data

9. Cronograma de Reavaliação

- ☐ 3 meses
☐ 6 meses
☐ 12 meses
☐ Outro: _____

10. Critérios de Alta / Continuidade

11. Notas Clínicas

Volume I – Módulo 10 - Relatório Clínico Integrado e Devolução de Resultados

Objetivo Clínico

Organizar a síntese final da avaliação psicológica, integrando a anamnese, observação clínica, instrumentos de avaliação, formulação de caso, conclusões diagnósticas e recomendações.

1. Identificação do Caso

2. Motivo da Avaliação

3. Instrumentos Aplicados

Instrumento	Data	Principais conclusões
Griffiths		
WPPSI/WISC		
BANC		
D2		
Figura Complexa de Rey		
ASEBA		
Conners		
BRIEF		
Outros		

4. Síntese dos Resultados

5. Formulação Clínica Integrada

6. Hipóteses Diagnósticas (DSM-5-TR / CID-11)

7. Diagnóstico Diferencial

8. Recomendações

9. Plano de Follow-up

Objetivo	Responsável	Prazo	Estado

10. Registo da Devolução aos Cuidadores/Escola

- ☐ Devolução aos pais/cuidadores
- ☐ Devolução à escola
- ☐ Relatório entregue
- ☐ Plano explicado

Observações:

11. Assinatura do Psicólogo

PICCA

Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

VOLUME II

Manual Clínico dos Marcos do Desenvolvimento (0–6 anos)

Módulo 1 – Fundamentos do Desenvolvimento Infantil

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Autora: Dra. Daniela Santos

Psicóloga | Cédula Profissional n.º 022377

Versão clínica editável – 2026

Documento original de apoio à avaliação e intervenção. A organização por áreas e idades inspira-se na lógica funcional do Guia Portage, sem reprodução literal dos itens do inventário.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Ficha técnica e finalidade

Este módulo apresenta os fundamentos conceptuais e clínicos necessários para interpretar marcos do desenvolvimento entre o nascimento e os 6 anos. Serve de base aos módulos seguintes do PICCA – Volume II, dedicados à observação por idade, identificação de sinais de alerta, formulação clínica e planeamento da intervenção.

Utilização prevista

Consulta clínica, avaliação do desenvolvimento, entrevista de anamnese, articulação com família e escola, definição de objetivos terapêuticos e monitorização da evolução.

Título	PICCA – Volume II Manual Clínico dos Marcos do Desenvolvimento (0–6 anos)
Módulo	1 – Fundamentos do Desenvolvimento Infantil
População-alvo	Crianças dos 0 aos 6 anos; pais/cuidadores; profissionais de educação e saúde.
Âmbito	Psicologia clínica e educacional; intervenção precoce; contexto pré-escolar.
Formato	Documento editável para utilização profissional.
Limites	Não substitui instrumentos padronizados, avaliação médica, diagnóstico diferencial ou julgamento clínico.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Conteúdos do módulo

1. 1. Desenvolvimento infantil: conceito e princípios
2. 2. Domínios do desenvolvimento
3. 3. Idade cronológica, idade corrigida e idade de desenvolvimento
4. 4. Desenvolvimento típico, atraso, desvio e regressão
5. 5. Variabilidade individual e contexto
6. 6. Fatores de risco e fatores de proteção
7. 7. Marcos do desenvolvimento e critérios de aquisição
8. 8. Sinais de alerta e tomada de decisão clínica
9. 9. Princípios de observação e interpretação
10. 10. Integração clínica e formulação inicial
11. 11. Checklists e grelhas de apoio
12. 12. Referências de enquadramento

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

1. Desenvolvimento infantil: conceito e princípios

O desenvolvimento infantil corresponde a um processo contínuo de mudança que integra maturação biológica, aprendizagem, participação social e adaptação às exigências do meio. A criança desenvolve competências através da interação entre características individuais, relações significativas, oportunidades de exploração e condições ambientais.

A avaliação clínica não se limita a verificar se uma competência está presente. Procura compreender como a criança a executa, em que contextos a utiliza, que apoio necessita, se a generaliza e qual o impacto funcional da sua ausência ou fragilidade.

Dimensão	Descrição clínica
Continuidade	O desenvolvimento decorre ao longo do tempo e resulta da consolidação progressiva de competências.
Sequencialidade	Muitas aquisições seguem uma ordem previsível, embora o ritmo varie entre crianças.
Integração	Motricidade, cognição, linguagem, socialização e autonomia influenciam-se mutuamente.
Plasticidade	A experiência, a relação e a intervenção podem modificar trajetórias, sobretudo nos primeiros anos.
Contextualização	O desempenho depende do ambiente, da familiaridade, da motivação, do estado físico e emocional.
Funcionalidade	A relevância clínica de uma dificuldade aumenta quando compromete participação, autonomia ou aprendizagem.

Princípio clínico

Um marco isolado raramente permite concluir sobre uma perturbação. A interpretação considera o padrão global, a intensidade, a persistência, a generalização e o impacto funcional.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

2. Domínios do desenvolvimento

O PICCA organiza a análise do desenvolvimento em domínios interdependentes. Esta organização facilita a recolha sistemática de informação e permite identificar perfis homogéneos, discrepantes ou assimétricos.

Dimensão	Descrição clínica
Motricidade global	Controlo postural, equilíbrio, deslocação, coordenação bilateral, planeamento motor e participação em atividades físicas.
Motricidade fina e visuomotora	Preensão, manipulação, coordenação olho-mão, construção, grafomotricidade e utilização funcional de objetos.
Cognição e aprendizagem	Exploração, permanência do objeto, resolução de problemas, categorização, memória, conceitos, raciocínio e competências pré-académicas.
Linguagem recetiva	Compreensão de palavras, ordens, relações, conceitos, perguntas e narrativas.
Linguagem expressiva	Vocalização, palavras, frases, morfossintaxe, vocabulário, narrativa e inteligibilidade.
Comunicação social e pragmática	Atenção partilhada, iniciativa, reciprocidade, uso de gestos, adequação comunicativa e manutenção da interação.
Socialização e brincadeira	Vínculo, imitação, jogo funcional e simbólico, interação com pares, cooperação, regras e compreensão social.
Regulação emocional e comportamento	Modulação da ativação, tolerância à frustração, flexibilidade, expressão emocional, controlo de impulsos e adaptação.
Autonomia e comportamento adaptativo	Alimentação, higiene, vestir, sono, controlo de esfíncteres, segurança e participação nas rotinas.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Processamento sensorial	Reatividade a sons, toque, movimento, textura, luz e procura ou evitamento de estímulos.
-------------------------	--

3. Idade cronológica, idade corrigida e idade de desenvolvimento

3.1 Idade cronológica

A idade cronológica corresponde ao tempo decorrido desde a data de nascimento. Constitui a referência principal para comparar aquisições com expectativas desenvolvimentais.

3.2 Idade corrigida

Na prematuridade, a idade corrigida considera o número de semanas que faltaram para completar 40 semanas de gestação. A sua utilização é especialmente relevante nos primeiros anos, devendo ser articulada com a história neonatal, a evolução clínica e as orientações da equipa médica.

3.3 Idade de desenvolvimento

A idade de desenvolvimento representa uma estimativa do nível funcional demonstrado numa área específica. Não equivale a diagnóstico, não deve ser tratada como medida absoluta e pode variar entre domínios. Uma criança pode apresentar idade funcional mais elevada numa área e mais baixa noutra.

Cuidado interpretativo

Evitar transformar uma estimativa de idade de desenvolvimento numa descrição global da criança. O perfil deve permanecer multidimensional e contextualizado.

4. Desenvolvimento típico, atraso, desvio e regressão

Dimensão	Descrição clínica
Variação típica	Aquisição mais cedo ou mais tarde dentro de uma amplitude compatível com a trajetória global e sem impacto funcional significativo.
Atraso do desenvolvimento	Aquisição de competências numa sequência globalmente esperada, mas

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

	num ritmo inferior ao previsto para a idade.
Desvio qualitativo	Forma atípica de adquirir ou usar competências, com características que não correspondem apenas a um ritmo mais lento.
Dissociação	Diferença clinicamente relevante entre áreas, por exemplo linguagem muito inferior à motricidade ou autonomia.
Estagnação	Período prolongado sem novas aquisições, apesar de oportunidades adequadas.
Regressão	Perda de competências previamente adquiridas. Exige valorização clínica e articulação médica célere.

A distinção entre atraso e desvio é particularmente importante. No atraso, a criança tende a percorrer etapas semelhantes às esperadas, mas mais lentamente. No desvio, observa-se uma organização qualitativamente diferente do comportamento, da comunicação, do jogo ou da adaptação.

Sinal prioritário

A regressão em linguagem, interação, motricidade, autonomia ou comportamento adaptativo deve ser documentada com precisão e encaminhada para avaliação especializada.

5. Variabilidade individual e contexto

A aquisição de competências varia em função de fatores biológicos, relacionais, culturais e ambientais. Uma avaliação rigorosa diferencia ausência real de competência de desempenho condicionado pela situação.

- ☐ Estado de sono, fome, dor ou doença.
- ☐ Ansiedade perante o avaliador ou espaço desconhecido.
- ☐ Familiaridade com os materiais e instruções.
- ☐ Oportunidades de aprendizagem e participação nas rotinas.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
 Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

- ☐ Exposição linguística e contexto bilingue ou multilingue.
- ☐ Estilo parental, expectativas e nível de ajuda fornecido.
- ☐ Condições sensoriais, motoras ou comunicativas.
- ☐ Motivação, interesse e tolerância à exigência.

Sempre que possível, o psicólogo recolhe dados em mais do que um contexto e compara relato parental, informação escolar, observação clínica e desempenho em instrumentos estruturados.

6. Fatores de risco e fatores de proteção

6.1 Fatores de risco

Dimensão	Exemplos	Registo clínico
Pré-natal	Exposição a substâncias, infeções, complicações gestacionais, restrição do crescimento, stress materno intenso.	
Perinatal/neonatal	Prematuridade, baixo peso, hipóxia, internamento prolongado, convulsões, dificuldades alimentares.	
Médico/neurológico	Doença crónica, alterações sensoriais, síndromes genéticas, lesão neurológica, dor persistente.	
Familiar/relacional	Stress parental, psicopatologia dos cuidadores, conflito intenso, baixa responsividade, instabilidade de cuidados.	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Ambiental/social	Privação de oportunidades, pobreza, isolamento, exposição a violência, absentismo ou baixa estimulação.	
Desenvolvimental	Atrasos prévios, regressão, dificuldades persistentes de regulação, comunicação ou interação.	

6.2 Fatores de proteção

- ☐ Relação afetiva estável e responsiva com cuidadores.
- ☐ Detecção e intervenção precoces.
- ☐ Rotinas previsíveis e ambiente organizado.
- ☐ Oportunidades frequentes de brincadeira e exploração.
- ☐ Boa articulação entre família, escola e profissionais.
- ☐ Acesso a cuidados de saúde e educação adequados.
- ☐ Competências parentais consistentes e ajustadas à criança.
- ☐ Interesses, curiosidade, iniciativa e áreas de competência da criança.

7. Marcos do desenvolvimento e critérios de aquisição

Um marco do desenvolvimento descreve uma competência funcional que costuma emergir numa determinada janela etária. No PICCA, os marcos orientam a observação, mas não substituem a análise clínica do processo, da qualidade e da generalização.

7.1 Sistema de cotação recomendado

Cotação	Definição	Critério prático	Implicação
A – Adquirido	Executa de forma espontânea e funcional.	Observado em diferentes momentos ou confirmado de forma consistente.	Competência consolidada.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
 Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

E – Emergente	Executa parcialmente, com ajuda ou de forma inconsistente.	Surge com modelagem, pista, apoio físico ou elevada motivação.	Alvo adequado para intervenção proximal.
N – Não observado	Não executa nas condições propostas.	Ausente em observação e sem confirmação noutros contextos.	Requer análise de pré-requisitos e impacto funcional.
NA – Não aplicável	A oportunidade, condição física ou contexto não permite avaliar.	A tarefa não é pertinente ou não foi possível administrar.	Reavaliar noutra situação.

7.2 Qualidade da aquisição

- ☐ Espontaneidade
- ☐ Precisão
- ☐ Consistência
- ☐ Generalização
- ☐ Velocidade/eficiência
- ☐ Necessidade de ajuda
- ☐ Adequação ao contexto
- ☐ Impacto funcional

Zona de desenvolvimento proximal

As competências emergentes constituem alvos prioritários quando a criança demonstra pré-requisitos, responde ao apoio e mantém envolvimento suficiente para aprender.

8. Sinais de alerta e tomada de decisão clínica

Um sinal de alerta indica necessidade de aprofundar a avaliação. A sua relevância aumenta quando é persistente, ocorre em vários contextos, envolve regressão,

compromete múltiplos domínios ou interfere de forma significativa com a participação da criança.

8.1 Indicadores transversais

- ☐ Perda de competências previamente adquiridas.
- ☐ Baixa resposta social ou ausência persistente de reciprocidade.
- ☐ Ausência ou fragilidade marcada da comunicação intencional.
- ☐ Dificuldades motoras que limitam exploração e participação.
- ☐ Reatividade sensorial intensa ou procura sensorial que interfere com as rotinas.
- ☐ Dificuldade persistente em alimentar-se, dormir ou regular estados de ativação.
- ☐ Comportamentos repetitivos ou rigidez com impacto funcional.
- ☐ Assimetria marcada entre áreas do desenvolvimento.
- ☐ Necessidade de ajuda muito superior à esperada para realizar rotinas básicas.
- ☐ Preocupação consistente dos pais, educadores ou profissionais.

8.2 Níveis de prioridade

Dimensão	Descrição clínica
Monitorização	Dificuldade ligeira, isolada, recente e sem impacto funcional relevante. Define-se período de observação e apoio.
Avaliação aprofundada	Sinais persistentes, discrepâncias entre áreas ou impacto na comunicação, aprendizagem, autonomia ou participação.
Encaminhamento prioritário	Regressão, suspeita neurológica, perda de força, alteração do estado de consciência, dificuldades graves de alimentação, segurança ou desenvolvimento global.

9. Princípios de observação e interpretação

A observação clínica combina situações espontâneas e tarefas estruturadas. O objetivo é criar oportunidades para a competência emergir sem transformar a sessão numa sequência rígida de testes.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

9.1 Sequência de observação

1. Acolher e permitir exploração livre.
2. Observar iniciativa, regulação e relação com o cuidador.
3. Introduzir materiais adequados à idade e aos interesses.
4. Modelar apenas quando necessário.
5. Aumentar gradualmente a exigência.
6. Registrar tipo de ajuda, tempo de resposta e qualidade.
7. Confirmar com os cuidadores se o comportamento ocorre noutros contextos.
8. Integrar resultados com história clínica e instrumentos formais.

9.2 Tipos de ajuda

Dimensão	Descrição clínica
Pista natural	Organização do ambiente ou apresentação do material.
Pista gestual	Apontar, olhar ou demonstrar direção.
Pista verbal	Repetir, simplificar ou segmentar a instrução.
Modelagem	Executar a ação para a criança imitar.
Ajuda física parcial	Orientar parte do movimento.
Ajuda física total	Executar com apoio direto; indica competência ainda não autónoma.

10. Integração clínica e formulação inicial

A interpretação dos marcos integra história do desenvolvimento, condições médicas, ambiente, comportamento observado, informação de vários informadores e resultados de instrumentos padronizados. O psicólogo formula hipóteses provisórias e atualiza-as à medida que recolhe dados.

10.1 Estrutura de integração

Padrão global de desenvolvimento:

Áreas fortes: _____

Áreas emergentes: _____

Áreas não adquiridas: _____

Discrepâncias entre domínios:

Impacto funcional: _____

Fatores predisponentes: _____

Fatores precipitantes: _____

Fatores de manutenção: _____

Fatores de proteção: _____

Hipóteses clínicas: _____

Necessidades de avaliação complementar:

10.2 Relação com instrumentos de avaliação

Fonte/Instrumento	Contributo	Integração
Anamnese	Trajetória, aquisições, regressões, saúde, contexto e preocupações.	_____ _____ _____
Observação clínica	Qualidade do comportamento, regulação, relação, jogo e estratégias.	_____ _____ _____
Griffiths	Perfil do desenvolvimento por áreas e quocientes de desenvolvimento.	_____ _____ _____
WPPSI/WISC	Funcionamento cognitivo e perfil de competências em idades aplicáveis.	_____ _____ _____

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Vineland/medidas adaptativas	Autonomia, comunicação, socialização e funcionalidade quotidiana.	
Questionários	Comportamento, atenção, funções executivas, emoção e adaptação em diferentes contextos.	
Informação escolar	Participação, aprendizagem, relações, rotinas e resposta ao apoio.	

11. Checklists e grelhas de apoio

11.1 Checklist de qualidade da avaliação

- ☐ Recolho informação de mais do que um contexto.
- ☐ Distingo desempenho espontâneo de desempenho com ajuda.
- ☐ Registo a qualidade, não apenas a presença da resposta.
- ☐ Considero idade corrigida quando clinicamente indicado.
- ☐ Analiso fatores sensoriais, motores, linguísticos e emocionais.
- ☐ Procuro sinais de regressão ou estagnação.
- ☐ Integro impacto funcional e participação.
- ☐ Identifico fatores de risco e proteção.
- ☐ Evito conclusões diagnósticas com base num item isolado.
- ☐ Defino necessidades de monitorização, avaliação ou encaminhamento.

11.2 Grelha de síntese do perfil

Área	Adequado	Emergente	Não observado	Impacto	Prioridade

Motricidade global	☐	☐	☐	_____	_____
Motricidade fina	☐	☐	☐	_____	_____
Cognição	☐	☐	☐	_____	_____
Linguagem recetiva	☐	☐	☐	_____	_____
Linguagem expressiva	☐	☐	☐	_____	_____
Comunicação social	☐	☐	☐	_____	_____
Brincadeira/socialização	☐	☐	☐	_____	_____
Regulação emocional	☐	☐	☐	_____	_____
Autonomia	☐	☐	☐	_____	_____
Sensorial	☐	☐	☐	_____	_____

11.3 Plano inicial de intervenção

Área	Linha de base	Objetivo SMART	Estratégias	Indicador de progresso

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
 Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

12. Referências de enquadramento

Este módulo utiliza uma abordagem clínica integrativa e funcional. A organização dos domínios e a lógica de verificação de competências inspiram-se no Guia Portage disponibilizado pela utilizadora, sem reprodução literal dos itens. Os módulos etários seguintes apresentam conteúdos originais adaptados à prática da psicologia clínica e educacional.

- American Psychiatric Association. Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-5-TR).
- World Health Organization. International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11).
- World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability and Health – Children and Youth Version.
- Center on the Developing Child at Harvard University. Recursos sobre desenvolvimento, relações responsivas e funções executivas.
- Guia Portage de Educação Pré-Escolar – escala funcional organizada por áreas e idades, utilizado como referência estrutural.

Nota ética e técnica

Os marcos servem para rastreio e formulação. A comunicação de resultados deve indicar limites, fontes de informação e grau de certeza clínica. O diagnóstico requer critérios formais, avaliação diferencial e integração multidisciplinar quando necessário.

Registo de utilização do módulo

Nome da criança: _____

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Data de nascimento: _____

Idade cronológica: _____

Idade corrigida (quando aplicável):

Data da avaliação: _____

Profissional: _____

Contextos consultados:

Instrumentos complementares:

Síntese clínica inicial:

PICCA

Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

VOLUME VI

CHECKLISTS CLÍNICAS DAS PERTURBAÇÕES DO NEURODESENVOLVIMENTO

Instrumento auxiliar para triagem clínica, formulação de hipóteses e organização da
avaliação

*Baseado na arquitetura diagnóstica do DSM-5-TR, em linguagem clínica original e
operacional*

Dra. Daniela Santos

Psicologia Educacional | Avaliação Psicológica | Neurodesenvolvimento

Versão 1.0 | 2026

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Nota de utilização

IMPORTANTE

Este volume não substitui o DSM-5-TR, a avaliação psicológica, a entrevista clínica, a observação direta, a análise do desenvolvimento nem o diagnóstico diferencial. As formulações apresentadas são paráfrases clínicas originais dos domínios diagnósticos e destinam-se exclusivamente a profissionais qualificados. A marcação de indicadores não equivale, por si só, à confirmação de diagnóstico.

A decisão diagnóstica deve apoiar-se em múltiplas fontes, considerar a idade e o nível de desenvolvimento, documentar prejuízo funcional, avaliar a presença em diferentes contextos e excluir explicações alternativas médicas, sensoriais, neurológicas, emocionais, socioculturais e educacionais.

Sistema de registo

Nome da criança/jovem _____	Data de nascimento / idade _____
Data(s) de avaliação _____	Profissional responsável _____
Informantes _____	Contextos avaliados _____
Motivo do pedido _____	Código interno do processo _____

Nível de evidência

Nível	Descrição	Exemplo de fonte	Uso clínico
E0	Sem informação suficiente	Indicador não explorado	Não concluir
E1	Referência isolada ou pouco consistente	Um informante, sem exemplos	Explorar
E2	Evidência convergente	Dois informantes ou observação compatível	Hipótese sustentada

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

E3	Evidência multimétodo e funcional	Entrevista, observação e provas	Integração diagnóstica
----	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------

Índice do volume

1. Perturbação do Desenvolvimento Intelectual
2. Atraso Global do Desenvolvimento
3. Perturbação da Linguagem
4. Perturbação dos Sons da Fala
5. Perturbação da Fluência com Início na Infância
6. Perturbação da Comunicação Social (Pragmática)
7. Perturbação do Espectro do Autismo
8. Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção
9. Perturbação Específica da Aprendizagem
10. Perturbação do Desenvolvimento da Coordenação
11. Perturbação dos Movimentos Estereotipados
12. Perturbações de Tiques
13. Outras Perturbações do Neurodesenvolvimento
14. Síntese Integrada e Formulação de Hipóteses

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Matriz transversal do neurodesenvolvimento

Indicadores gerais

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
As dificuldades tiveram início no período do desenvolvimento ou tornaram-se evidentes quando as exigências ultrapassaram as capacidades disponíveis.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
O padrão é persistente e não se limita a uma fase breve, crise situacional ou alteração aguda.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Existe discrepância clinicamente relevante face ao esperado para a idade, escolaridade, experiência e contexto sociocultural.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Há impacto funcional na aprendizagem, comunicação, autonomia, comportamento, relações ou participação social.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
As dificuldades estão presentes em mais de um contexto, quando a natureza do quadro assim o exige.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foram recolhidos dados de múltiplos informantes e métodos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foram consideradas condições médicas, neurológicas, sensoriais, do sono e efeitos de medicação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foram consideradas experiências adversas, ansiedade, humor, trauma, fatores familiares e qualidade das oportunidades educativas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Foram consideradas diferenças linguísticas, culturais e de exposição pedagógica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
O perfil inclui forças, interesses, competências preservadas e fatores protetores.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Síntese transversal inicial

1. Perturbação do Desenvolvimento Intelectual

Explorar conjuntamente o funcionamento intelectual e o funcionamento adaptativo. A gravidade clínica deve ser formulada sobretudo a partir das necessidades de apoio no quotidiano, e não apenas por um resultado de QI.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Funcionamento intelectual

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldades persistentes no raciocínio, resolução de problemas e aprendizagem de conceitos novos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Necessidade de maior repetição, mediação ou ensino explícito para consolidar aprendizagens.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em generalizar competências entre tarefas ou contextos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Desempenho intelectual global abaixo do esperado em avaliação padronizada válida, interpretada com cautela.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Perfil cognitivo coerente com limitações globais, não explicado apenas por défice linguístico, sensorial ou escolar.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Funcionamento adaptativo — domínio conceptual

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldades significativas na linguagem funcional, literacia, numeracia, noção de tempo ou uso do dinheiro.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em compreender regras, consequências, sequências e exigências académicas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Necessidade de apoio para planear, organizar ou concluir tarefas adequadas à idade.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Funcionamento adaptativo — domínio social

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldade em interpretar pistas sociais, intenções, risco, confiança e reciprocidade.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Julgamento social imaturo ou vulnerabilidade à influência/manipulação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em ajustar comunicação e comportamento à situação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Funcionamento adaptativo — domínio prático

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Necessidade de apoio acima do esperado em autocuidado, segurança, deslocações ou rotinas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldades na gestão de responsabilidades	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
domésticas, escolares ou laborais.					
Dependência de supervisão para manter saúde, segurança ou funcionamento diário.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Défices intelectuais sustentados por avaliação clínica e psicométrica apropriada.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Défices adaptativos que limitam independência e responsabilidade social.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início durante o período do desenvolvimento.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Condições sensoriais, neurológicas, linguísticas e socioculturais consideradas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Atraso global do desenvolvimento; perturbação específica da aprendizagem; perturbação da linguagem; PEA; PHDA; lesão neurológica; privação educacional; dificuldades sensoriais.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

2. Atraso Global do Desenvolvimento

Categoria clínica reservada sobretudo a crianças pequenas quando existem atrasos significativos em várias áreas e a avaliação intelectual sistemática ainda não é possível ou fiável. Requer reavaliação periódica.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Áreas do desenvolvimento

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Atraso relevante em duas ou mais áreas: cognição, linguagem, motricidade, socialização, autonomia ou competências adaptativas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Marcos desenvolvimentais adquiridos mais tarde, de forma lenta ou com trajetória atípica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Necessidade de suporte intensivo e transversal para aprender competências básicas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Resultados convergentes em escalas de desenvolvimento, observação e relato dos cuidadores.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Perfil não adequadamente explicado por uma dificuldade isolada numa única área.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Qualidade e trajetória

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Presença de platôs prolongados ou progressão muito inferior à esperada.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Perda de competências previamente adquiridas ou regressão — indicador para avaliação médica/neurológica urgente.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Variabilidade marcada entre contextos ou momentos, exigindo análise de fatores sensoriais, médicos e relacionais.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Atraso significativo em múltiplos domínios.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Idade ou condições de avaliação não permitem caracterização intelectual conclusiva.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início no período do desenvolvimento.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Plano de reavaliação e monitorização definido.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Perturbação do desenvolvimento intelectual; perturbação da linguagem; PEA; paralisia cerebral; défices auditivos/visuais; doenças genéticas/metabólicas; privação psicossocial.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

3. Perturbação da Linguagem

Avaliar aquisição e uso da linguagem em modalidades relevantes, distinguindo forma, conteúdo e uso. Considerar exposição linguística, audição, desenvolvimento cognitivo e qualidade das oportunidades comunicativas.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Compreensão e expressão

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Vocabulário reduzido ou dificuldade persistente em aprender e recuperar palavras.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Frases curtas, estruturas gramaticais imaturas ou erros morfossintáticos persistentes.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em compreender instruções, perguntas, conceitos ou linguagem complexa.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em organizar narrativas, explicar acontecimentos ou manter coerência discursiva.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Desempenho linguístico inferior ao esperado para idade e exposição, confirmado por avaliação apropriada.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Impacto e curso

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Interferência na comunicação quotidiana, relações, aprendizagem ou participação escolar.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Início durante o desenvolvimento, ainda que o impacto se torne mais evidente com maiores exigências.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldades persistem apesar de oportunidades adequadas de aprendizagem e estimulação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
O perfil não é melhor explicado por perda auditiva, condição neurológica, deficiência intelectual ou domínio insuficiente da língua de avaliação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Dificuldades persistentes na aquisição e uso da linguagem.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Competências linguísticas abaixo do esperado para idade e contexto.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Impacto funcional clinicamente significativo.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Exclusões e fatores linguísticos/culturais adequadamente analisados.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Perturbação dos sons da fala; perturbação da comunicação social; PEA; défice auditivo; perturbação intelectual; perturbação específica da aprendizagem; exposição bilingue insuficientemente considerada.

Instrumentos e fontes possíveis

- ☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da
linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

4. Perturbação dos Sons da Fala

Explorar a produção de sons, inteligibilidade e padrões fonológicos, distinguindo variações normativas, diferenças linguísticas, alterações estruturais, sensoriais e motoras.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Produção e inteligibilidade

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldade persistente na produção correta de sons esperados para a idade e variante linguística.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Fala pouco inteligível para interlocutores não familiares ou, em casos mais graves, também para familiares.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Erros articulatórios ou fonológicos que limitam a clareza da mensagem.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Evitação de palavras, simplificação excessiva ou frustração associada à fala.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Impacto na comunicação, relações, participação escolar ou desempenho académico.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de enquadramento

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Início no período do desenvolvimento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Os erros excedem o esperado para a idade e não correspondem apenas a sotaque ou variação dialetal.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foram avaliadas audição, estruturas orofaciais e fatores motores/neurológicos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foi considerada apraxia da fala na infância quando existem inconsistência, dificuldades de planeamento motor e alterações prosódicas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Dificuldade persistente e desenvolvimental na produção dos sons.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Redução de inteligibilidade ou impacto funcional.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Variação linguística e maturação consideradas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Condições sensoriais, estruturais e motoras avaliadas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Perturbação da linguagem; apraxia da fala na infância; disartria; perda auditiva; fissura palatina; variação dialetal; PEA.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

5. Perturbação da Fluência com Início na Infância

Caracterizar frequência, tipos de disfluência, tensão, evitamento e impacto. As disfluências devem ser interpretadas em função da idade, contexto, curso e reação emocional.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Fluência e ritmo

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Repetições frequentes de sons, sílabas ou palavras curtas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Prolongamentos de sons ou bloqueios audíveis/silenciosos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Palavras produzidas com tensão física excessiva.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Interrupções, circunlóquios ou substituições para evitar palavras temidas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Ansiedade antecipatória, evitamento de falar ou redução da participação comunicativa.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Perturbação do ritmo e fluência inadequada à idade, com impacto funcional.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Curso e exclusões

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Início durante o desenvolvimento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Varia consoante interlocutor, exigência, excitação ou pressão temporal.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Não é melhor explicada por condição neurológica, lesão, efeito de substância ou outra alteração médica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
São considerados antecedentes familiares e evolução temporal.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Alteração persistente da fluência e organização temporal da fala.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Inadequação à idade e competências linguísticas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Ansiedade, evitamento ou limitação comunicativa.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início na infância e exclusões relevantes analisadas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Disfluência desenvolvimental transitória; tiques vocais; perturbação de ansiedade social; alterações neurológicas; taquifemia.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

6. Perturbação da Comunicação Social (Pragmática)

A hipótese só deve ser considerada quando existem dificuldades pragmáticas persistentes e não estão presentes padrões restritos/repetitivos suficientes para PEA.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Uso social da comunicação

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldade em utilizar comunicação para cumprimentar, partilhar informação, pedir ajuda ou adequar-se ao contexto.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em adaptar linguagem à pessoa, situação, idade ou grau de formalidade.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em seguir regras de conversação, alternar turnos, reformular e reparar mal-entendidos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em compreender inferências, humor, ironia, ambiguidades ou linguagem não literal.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em integrar contexto, expressão facial, tom de voz e conhecimento partilhado.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Impacto e exclusão de PEA

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Limitações na participação social, relações, desempenho académico ou funcionamento profissional.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Início no desenvolvimento, podendo tornar-se evidente apenas com exigências sociais complexas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Não existem padrões restritos/repetitivos atuais ou históricos suficientes para explicar o quadro como PEA.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Não é melhor explicada por perturbação da linguagem, deficiência intelectual ou condição neurológica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Dificuldades persistentes no uso social da comunicação verbal e não verbal.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Impacto funcional relevante.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início no desenvolvimento.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
PEA e outras explicações foram cuidadosamente excluídas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

PEA; perturbação da linguagem; PHDA; ansiedade social; deficiência intelectual; dificuldades pragmáticas secundárias a trauma ou privação social.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

7. Perturbação do Espectro do Autismo

A formulação exige evidência nos três domínios de comunicação/interação social e em pelo menos dois grupos de comportamentos restritos ou repetitivos, com início desenvolvimental e impacto funcional. Registrar história atual e passada.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

A. Reciprocidade socioemocional

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldade em iniciar ou responder a interações sociais de forma ajustada.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Partilha reduzida ou atípica de interesses, emoções, prazer ou atenção.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Conversação pouco recíproca, unilateral ou limitada à resposta instrumental.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Abordagens sociais incomuns, pouca leitura da resposta do outro ou dificuldade em manter intercâmbio.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

A. Comunicação não verbal

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Contacto ocular, gestos, postura, expressão facial ou prosódia pouco integrados com a comunicação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em compreender ou utilizar gestos	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
convencionais, apontar, mostrar ou coordenar atenção conjunta.					
Expressão não verbal limitada, atípica, excessiva ou difícil de interpretar.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Desfasamento entre comunicação verbal e sinais não verbais.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

A. Relações e compreensão social

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldade em ajustar comportamento a diferentes contextos sociais.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em desenvolver, compreender ou manter relações adequadas ao nível de desenvolvimento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Brincadeira imaginativa partilhada limitada, rígida ou pouco recíproca.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Interesse reduzido pelos pares ou forma atípica de aproximação e participação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

B. Padrões restritos/repetitivos

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Movimentos, uso de objetos ou fala repetitiva/estereotipada.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Rigidez, insistência em rotinas, sofrimento com mudanças ou necessidade intensa de previsibilidade.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Interesses muito intensos, circunscritos ou incomuns quanto ao foco e persistência.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Hiper ou hiporreatividade sensorial, procura sensorial ou interesse invulgar por aspetos sensoriais.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Curso, impacto e especificadores

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Características presentes no início do desenvolvimento, mesmo que mascaradas ou evidentes apenas mais tarde.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Impacto clinicamente significativo no funcionamento social, escolar, familiar ou adaptativo.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
O quadro não é explicado apenas por deficiência intelectual; quando coexistem, as dificuldades sociais excedem o nível global de desenvolvimento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Registar linguagem, funcionamento intelectual, condições médicas/genéticas, catatonia e necessidades de apoio.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Evidência em todos os três domínios de comunicação/interação social.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Evidência em pelo menos dois grupos de comportamentos restritos/repetitivos.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Início no período do desenvolvimento.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Impacto funcional significativo.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Deficiência intelectual e outras hipóteses diferenciais consideradas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Perturbação da comunicação social; perturbação da linguagem; deficiência intelectual; PHDA; ansiedade social; perturbação reativa de vinculação; TOC; condições sensoriais.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

8. Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção

Registrar sintomas em linguagem operacional, frequência, duração, início antes dos 12 anos, presença em dois ou mais contextos e prejuízo. Para crianças, habitualmente exige-se um limiar superior ao utilizado em adolescentes mais velhos e adultos.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Desatenção

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Comete erros por descuido ou não repara em detalhes relevantes.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em sustentar a atenção em tarefas, brincadeiras ou conversas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Parece não ouvir quando lhe falam diretamente, sem causa aparente.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Não termina instruções, trabalhos ou rotinas, apesar de compreender o pedido.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em organizar tarefas, materiais, tempo e sequências.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Evita ou adia tarefas que exigem esforço mental continuado.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Perde objetos necessários às atividades.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Distrai-se facilmente por estímulos externos ou pensamentos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Esquece atividades, compromissos ou etapas de rotinas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Hiperatividade e impulsividade

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Movimenta mãos/pés, remexe-se ou revela inquietação motora.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Levanta-se quando seria esperado permanecer sentado.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Corre, trepa ou sente inquietação interna em situações inadequadas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em brincar ou ocupar-se de forma tranquila.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Está frequentemente em movimento como se tivesse dificuldade em abrandar.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Fala em excesso ou prolonga respostas para além do necessário.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Responde antes de a pergunta terminar ou precipita respostas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em esperar pela sua vez.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Interrompe, intromete-se ou utiliza objetos/atividades de outros sem esperar.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições diagnósticas transversais

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Vários sintomas estavam presentes antes dos 12 anos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Os sintomas ocorrem em pelo menos dois contextos relevantes.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Existe evidência clara de interferência ou redução da qualidade do funcionamento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
O padrão persiste há pelo menos seis meses e é desajustado ao nível de desenvolvimento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Os sintomas não ocorrem exclusivamente durante perturbação psicótica e não são melhor explicados por ansiedade, humor, trauma, sono, aprendizagem, PEA ou outra condição.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Limiar sintomático e duração clinicamente compatíveis.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início de vários sintomas antes dos 12 anos.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Presença em dois ou mais contextos.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Prejuízo funcional claro.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Diagnóstico diferencial e comorbilidades avaliados.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Ansiedade; depressão; trauma; perturbações do sono; PEA; perturbação da aprendizagem; deficiência intelectual; altas capacidades; dificuldades auditivas; ambiente pouco estruturado.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

9. Perturbação Específica da Aprendizagem

A hipótese requer dificuldades académicas persistentes apesar de intervenção dirigida, abaixo do esperado e com impacto funcional. Interpretar provas formais à luz da história escolar, qualidade do ensino e resposta à intervenção.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Leitura

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Leitura de palavras lenta, imprecisa ou laboriosa.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade persistente na descodificação e automatização.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em compreender o significado do que lê, mesmo quando a descodificação é suficiente.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Ortografia fonologicamente inconsistente ou dificuldade em reconhecer padrões ortográficos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Expressão escrita

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Erros ortográficos persistentes acima do esperado.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldades gramaticais, de pontuação ou construção frásica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Texto pouco organizado, incoerente ou muito reduzido.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Produção escrita lenta, com grande esforço ou evitamento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Matemática

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Compreensão frágil de número, magnitude e relações numéricas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em memorizar factos aritméticos ou executar cálculos com precisão/fluência.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Erros persistentes em procedimentos, alinhamento, sinais ou sequências.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldade em aplicar raciocínio matemático a problemas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Dificuldades persistem durante pelo menos seis meses apesar de apoio dirigido e monitorizado.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Desempenho claramente abaixo do esperado para idade e escolaridade, com impacto académico ou quotidiano.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Início durante os anos escolares, ainda que se torne	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
evidente apenas quando aumentam as exigências.					
Não é melhor explicado por deficiência intelectual, défices sensoriais, condição neurológica, adversidade psicossocial, língua de escolarização ou instrução inadequada.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Dificuldades persistentes em leitura, escrita e/ou matemática.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Resposta insuficiente a intervenção adequada.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Desempenho abaixo do esperado e impacto funcional.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início escolar e exclusões documentadas.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Deficiência intelectual; PHDA; perturbação da linguagem; absentismo; ensino inadequado; dificuldades emocionais; défices visuais/auditivos; diferenças linguísticas.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

--

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

10. Perturbação do Desenvolvimento da Coordenação

Avaliar aquisição e execução de competências motoras, impacto nas atividades diárias e relação com idade e oportunidades de aprendizagem.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Coordenação motora

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Aquisição de marcos motores ou competências motoras mais lenta do que o esperado.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Movimentos desajeitados, imprecisos ou lentos em tarefas como correr, saltar, lançar ou apanhar.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Dificuldades em motricidade fina: escrita, desenho, recorte, botões, talheres ou construção.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Necessidade de esforço excessivo, repetição ou tempo adicional em tarefas motoras.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Evita atividades físicas, jogos de bola ou tarefas manuais por dificuldade ou frustração.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Impacto e exclusões

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Interferência relevante em	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
autocuidado, desempenho escolar, lazer ou participação social.					
Início no período do desenvolvimento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
As dificuldades não são explicadas por deficiência intelectual, défice visual ou condição neurológica motora.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Quando existe PEA ou PHDA, a dificuldade motora é clinicamente adicional e não apenas consequência de desatenção.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Competências motoras substancialmente abaixo do esperado.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Impacto funcional significativo.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início no desenvolvimento.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Exclusão de condições neurológicas, visuais e intelectuais.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Paralisia cerebral; distrofias; perturbações neuromusculares; défice visual; deficiência intelectual; PHDA; dispraxia verbal; hiper mobilidade.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

11. Perturbação dos Movimentos Estereotipados

Caracterizar forma, frequência, função, risco e possibilidade de interrupção dos movimentos. Avaliar sempre causas neurológicas, efeitos de medicação e comportamentos autolesivos.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Padrão motor

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Movimentos repetitivos, aparentemente sem objetivo funcional imediato.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Comportamentos como balançar, agitar mãos, bater a cabeça, morder-se ou manipular o corpo de forma repetida.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Movimentos interferem com atividades ou participação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Existe risco de lesão ou necessidade de medidas de proteção.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
O padrão iniciou-se no período do desenvolvimento.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Enquadramento

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
O comportamento não é explicado por substância, medicação ou condição neurológica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Não corresponde apenas a compulsão, tique, tricotilomania ou comportamento repetitivo típico de PEA.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Registrar associação a deficiência intelectual, condição genética, sensorial ou ambiental.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Caracterizar presença de autoagressão e gravidade.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Comportamento motor repetitivo e sem função aparente.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Interferência funcional ou risco de lesão.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início no desenvolvimento.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Diagnósticos diferenciais e causas médicas analisados.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Tiques; compulsões; PEA; tricotilomania; crises epiléticas; acatisia; efeitos de fármacos; autoestimulação sensorial.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

PICCA – Protocolo Integrado de Conceptualização Clínica e Avaliação

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

12. Perturbações de Tiques

Distinguir tiques motores e vocais, simples e complexos; documentar idade de início, duração, flutuação, supressibilidade, impulso premonitório e impacto.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Caracterização dos tiques

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Movimentos súbitos, rápidos, recorrentes e não rítmicos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Vocalizações súbitas e recorrentes.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Os sintomas variam em frequência, intensidade e localização ao longo do tempo.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Podem ser parcialmente suprimidos durante períodos curtos, com aumento de tensão.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Existe impulso premonitório, alívio após o tique ou agravamento com stress/fadiga.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Classificação temporal

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Existem tiques motores múltiplos e pelo menos um tique vocal em algum momento da evolução.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Os tiques persistem por período superior	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
a um ano desde o primeiro início.					
Quando a duração é inferior a um ano, considerar apresentação provisória.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Quando existe apenas tique motor ou apenas vocal persistente, considerar apresentação persistente específica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Início ocorreu antes dos 18 anos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Não é atribuível a substância, medicação ou condição neurológica.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Natureza motora e/ou vocal documentada.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Duração e curso claramente estabelecidos.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Início antes dos 18 anos.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Exclusão de causas médicas, farmacológicas e movimentos não-tique.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Estereotipias; compulsões; mioclonias; distonia; crises epiléticas; hábitos nervosos; movimentos induzidos por fármacos.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

13. Outras Perturbações do Neurodesenvolvimento

Utilizar apenas quando existe prejuízo clinicamente significativo e o perfil não satisfaz integralmente outra categoria, ou quando a informação é insuficiente para maior especificação.

Orientação clínica

Assinalar apenas indicadores sustentados por exemplos concretos. Registrar frequência, intensidade, duração, contexto, impacto e fonte. Evitar somas mecânicas sem análise qualitativa.

Perturbação especificada

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Existe um padrão neurodesenvolvimental clinicamente significativo.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
É possível indicar a razão pela qual os critérios completos de uma categoria não são satisfeitos.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
A formulação descreve explicitamente a apresentação atípica, subclínica, tardia ou limitada.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foram avaliadas condições médicas, sensoriais, ambientais e emocionais.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Perturbação não especificada

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
Existe prejuízo importante, mas a informação disponível é insuficiente para uma categoria mais precisa.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
A situação clínica, urgência ou ausência de dados impede	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
especificação adequada.					
Está definido um plano para recolha adicional de informação e reavaliação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Condições de decisão clínica

Condição de decisão clínica	Estado	Evidência / fundamentação
Prejuízo neurodesenvolvimental clinicamente relevante.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Razão para não preencher categoria específica documentada.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Uso prudente e provisório quando a informação é insuficiente.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	
Plano de investigação/reavaliação definido.	☐ Sim ☐ Não ☐ Incerto	

Diagnóstico diferencial e comorbilidades a explorar

Variação do desenvolvimento; dificuldades situacionais; reação emocional; insuficiência de dados; problemas pedagógicos; condição médica não identificada.

Instrumentos e fontes possíveis

☐ Entrevista clínica ☐ Anamnese desenvolvimental ☐ Observação ☐ Informação escolar
☐ Relatórios médicos/terapêuticos ☐ Medidas adaptativas ☐ Provas cognitivas/neuropsicológicas ☐ Questionários multi-informante ☐ Avaliação da linguagem/motricidade/aprendizagem

Síntese clínica e hipótese provisória

Evidência que sustenta / contradiz a hipótese

14. Síntese Integrada e Formulação de Hipóteses

Mapa de hipóteses

Hipótese	Evidência a favor	Evidência contra	Dados em falta	Estado
				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída
				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída
				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída
				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída
				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída
				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída

966419142

danielosantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)

Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)

				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída
				☐ Principal ☐ Diferencial ☐ Comórbida ☐ Excluída

Integração nos 5 P

Fatores predisponentes

Fatores precipitantes

Fatores perpetuantes

Fatores protetores

Problema atual e impacto funcional

Decisão e próximos passos

Plano clínico

Indicador clínico (linguagem operacional)	N	O	F	Fontes / contextos	Notas
A hipótese principal está sustentada por dados de múltiplas fontes.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Os critérios de duração, início, contexto e impacto estão documentados.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
As hipóteses diferenciais prioritárias foram avaliadas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
As comorbidades foram consideradas.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foi avaliada a necessidade de referência médica, neuropsiquiátrica, pedopsiquiátrica, terapia da fala, terapia ocupacional ou apoio educativo.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foram identificadas adaptações imediatas para casa e escola.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foi definido plano de intervenção e monitorização.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	
Foi definida data de reavaliação.	☐	☐	☐	☐ Casa ☐ Escola ☐ Clínica ☐ Outros	

Legenda: N = não observado/ausente; O = observado mas insuficientemente caracterizado; F = evidência frequente, persistente ou clinicamente relevante.

Formulação conclusiva para relatório

Devolução aos pais/cuidadores em linguagem acessível

Recomendações para a escola

Referências e enquadramento

American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR).

American Psychiatric Association. Neurodevelopmental Disorders – patient and family educational resources.

Centers for Disease Control and Prevention. Clinical Testing and Diagnosis for Autism Spectrum Disorder.

Centers for Disease Control and Prevention. Diagnosing ADHD / Clinical Care of ADHD in Children.

American Psychiatric Association. What Are Specific Learning Disorders?

American Speech-Language-Hearing Association. Practice and evidence resources on language, speech sound and social communication disorders.

Nota editorial e de propriedade intelectual

As listas deste volume utilizam redação original e funcional, baseada nos domínios clínicos reconhecidos no DSM-5-TR. Não constituem reprodução integral dos critérios oficiais. Para decisões diagnósticas formais deve ser consultado o manual oficial atualizado.

966419142

danielasantos.consultas@gmail.com

Morada: Rua Américo Costa 6 - Bairro CHEPSI Póvoa de Santa Iria (Frente APAC)
Morada: Rua dos Forcados Amadores de Azambuja (Frente Mundo Pinguim)